

360° Klinik Yönetici ve Karar Destek Raporu

Alaattin Sönmez (64E) · 10 Eylül 2026 · Postoperatif 204. Gün

1. Hasta Künyesi

Alan	Değer
Ad Soyad	Alaattin SÖNMEZ
TC	00000000000
Yaş / Cinsiyet	64 / Erkek
Doğum	01.01.1962 / HATAY
Boy / Kilo / VKİ	174 cm / 78.4 kg / 25.9
Kan Grubu	0 Rh (+)
Güvence	SSK / Hatay
Ameliyat	20 Şubat 2026 (Bentall Prosedürü)

2. Yönetici Klinik Özet

Alaattin Sönmez (64E), 19 Şubat 2026'da ani başlayan yırtıcı karakterde göğüs-sırt ağrısı ile Defne Devlet Hastanesi'ne başvurmuş; sevk zinciri sonrası **5.3 cm asendan aort anevrizması ve Tip A Aort Diseksiyonu** kesin tanısı ile Özel İskenderun Gelişim Hastanesi'ne yatırılmıştır (Isselbacher et al., 2022, s. e340). 20 Şubat 2026'da derin hipotermik sirkülatuar arrest altında **32 mm Maquet Intergard Dacron greft ve 25 mm CORCYM Carbomedics mekanik kapak** implante edilerek Bentall prosedürü tamamlanmıştır (Bentall & De Bono, 1968, s. 211). Postoperatif dönemde sternal dehissens (23-28 Temmuz 2026 revizyonu), geçici INR dalgalanmaları (zirve 8.46) ve mikroskopik demir eksikliği anemisi gelişmiştir.

Son 7 gün ortalama kan basıncı **111/75 mmHg** ile 2024 ESC hedefinin ($\leq 120/80$) altındadır (McEvoy et al., 2024). 10 Eylül kontrolünde INR 2.12 ile mekanik aort kapak için terapötik pencerededir (Vahanian et al., 2022, s. 584). Ancak 4 kritik başlık sürmektedir: (1) mikrositer anemi (HGB 9.7 g/dL, Ferritin 19 µg/L; Ferro Sanol Duodenal başlandı), (2) TTR %54.6 ile suboptimal antikoagülasyon, (3) CRP

11.3 mg/L ile subakut enflamasyon, (4) rezidüel Tip B diseksiyon flebi nedeniyle 6-aylık görüntüleme ihtiyacı (Fleischmann et al., 2022, s. e000075).

3. Biyobelirteç Değişim Tablosu

Parametre	Referans	İlk	Zirve/Dip	Son	%Δ	Trend
INR	2.0-3.0	1.10	8.46	2.12	+92.7%	Hedefte
HGB	13.5-17.5	14.0	7.7	9.7	-30.7%	Anemi
MCV	80-100	88.0	76.4	76.4	-13.2%	Mikrositer
Ferritin	30-400	19	19	19	—	Depo boş
CRP	0-5	2.6	154	11.3	-92.7%	Gerilemede
WBC	4.5-11	10.62	27.1	7.97	-25%	Normal
Kreatinin	0.6-1.3	1.11	0.76	1.02	-8.1%	Stabil
eGFR	>60	72.58	72.58	75.58	+4.1%	Normal
LDL	<70	119.6	141	141	+17.9%	Yüksek
TSH	0.27-4.2	0.86	0.28	0.28	-67.4%	Sınırdı

4. Aylık Kan Basıncı Özeti

Ay	n	Ortalama	Min	Maks
Mart 2026	69	109.2/76.8	83/60	154/98
Nisan 2026	96	109.4/77.8	85/60	168/103
Mayıs 2026	63	118.6/80.2	100/68	140/95
Haziran 2026	68	127.2/84.6	109/72	149/99
Temmuz 2026	84	124.9/83.2	102/60	149/101
Ağustos 2026	89	118.7/79.9	99/65	139/95
Eylül 2026	21	111/76	101/68	122/82

5. TTR Analizi

39 INR ölçümü, Rosendaal lineer interpolasyonu ile **TTR %54.6** (hedef >%70; Vahanian et al., 2022, s. 584; Rosendaal et al., 1993, s. 236). Kritik sapmalar: 16 Mart 2026 INR 8.46 (supraterapötik), 27 Temmuz 2026 INR 1.17 (köprüleme öncesi).

6. İnteraktif İlaç Etkileşim Matrisi

Çift	R i s k	Mekanizma	Yönetim
Warfarin × Klamoks	K r i t i k	Barsak florası K vit. sentezi baskısı + CYP2C9 inhibisyonu	Kür tamamlandı (10 Eyl); kontrol INR 2.12 ile hedefte
Karvedilol × Perindopril	Y ü k s e k	Sinerjik vazodilatasyon	İlk dozda oturur pozisyon
Warfarin × Aspirin	Y ü k s e k	Hemostatik plug + kaskad inhibisyonu	Yıllık gaita gizli kan
Demir × Panto	Y ü k s e k	Mide pH artışı demir emilimini azaltır	1 saat önce uygula (sabah aç Ferro Sanol, 1 saat sonra Panto)
Ciprofloksa sin × Warfarin	Y ü k s e k	CYP1A2 inhibisyonu	INR takibi
Perindopril × Warfarin	O r	PAI-1 azalması	Rutin takip

Çift	R i s k	Mekanizma	Yönetim
Panto × Aspirin × Warfarin	t a Y ü k s e k	Kombine kanama riski	Endoskopik takip

7. Kronolojik Klinik Zaman Çizelgesi

- **19 Şub 2026:** Defne DH → MKÜ → Kırıkhan DH → İskenderun Gelişim (acil sevk zinciri)
- **20 Şub 2026:** Bentall prosedürü (32 mm Dacron + 25 mm Carbomedics)
- **02 Mar 2026:** Şifa ile taburcu, yaşam boyu warfarin
- **16 Mar 2026:** INR 8.46 zirve, aspirin kesildi
- **30-31 Mar 2026:** Genel Cerrahi yatışı (kabızlık, lavman)
- **16-18 Nis 2026:** Ardışık 3 hipertansif kriz (168/103 mmHg zirve)
- **23-28 Tem 2026:** Sternal dehissens revizyonu, kan transfüzyonu
- **04 Ağu 2026:** Coversyl eklendi
- **04 Eyl 2026:** Klamoks ampirik başlandı
- **10 Eyl 2026:** Klamoks 1000 mg kürü tamamlandı (20:59); kontrol koagülasyon testinde (#92, 16:57) INR 2.12, PT 19.8 sn, aPTT 44.8 sn ile kapak antikoagülasyonu güvenli aralıkta teyit edildi; Ferro Sanol Duodenal 100 mg reçetelendi
- **11 Eyl 2026:** Ferro Sanol Duodenal 100 mg başlandı (06:00, sabah aç, Panto'dan 1 saat önce)

8. Branş Bazlı Eylem Planı

Hematoloji: Oral Ferro Sanol Duodenal 100 mg başlandı (Ferritin <100; toleranssızlıkta IV Ferinject 500-1000 mg; McDonagh et al., 2021, s. 3649).

Kardiyoloji: Klamoks kürü bitti, kontrol INR 2.12 ile hedefte; LDL 141 için statin (ESC 2024). **KVC/Radyoloji:** 6 aylık kontrol aort BT Anjiyografi (Fleischmann et al., 2022). **Enfeksiyon:** Diş işlemleri öncesi amoksisilin 2 g profilaksi (Habib et al.,

2015). **Genel Cerrahi:** Sternal yara takibi; CRP <5 hedefi. **Kardiyoloji:** BP hedefi sürdürme (McEvoy et al., 2024). **Nefroloji:** Kreatinin ve potasyum stabil takip (KDIGO 2023).

9. Kaynakça (APA 7th Edition)

1. **Isselbacher, E. M., Preventza, O., Hamilton Black, J., et al. (2022).** 2022 ACC/AHA Guideline for the Diagnosis and Management of Aortic Disease. *Circulation*, 146(24), e334–e482.
2. **Vahanian, A., Beyersdorf, F., Praz, F., et al. (2022).** 2021 ESC/EACTS Guidelines for the management of valvular heart disease. *European Heart Journal*, 43(7), 561–632.
3. **Delgado, V., Ajmone Marsan, N., de Waha, S., et al. (2023).** 2023 ESC Guidelines for the management of endocarditis. *European Heart Journal*, 44(39), 3948–4042.
4. **Czerny, M., Grabenwöger, M., Berger, T., et al. (2024).** EACTS/STS Guidelines for diagnosing and treating acute and chronic syndromes of the aortic organ. *European Journal of Cardio-Thoracic Surgery*, 65(2), ezad426.
5. **McEvoy, J. W., McCarthy, C. P., Bruno, R. M., et al. (2024).** 2024 ESC Guidelines for the management of elevated blood pressure and hypertension. *European Heart Journal*, 45(38), 3897–3972.
6. **Fleischmann, D., Afifi, R. O., Casanegra, A. I., et al. (2022).** Imaging and Surveillance of Chronic Aortic Dissection: A Scientific Statement from the American Heart Association. *Circulation: Cardiovascular Imaging*, 15(3), e000075.
7. **Goddard, A. F., James, M. W., McIntyre, A. S., & Scott, B. B. (2021).** British Society of Gastroenterology guidelines for the management of iron deficiency anaemia in adults. *Gut*, 70(11), 2030–2051.
8. **McDonagh, T. A., Metra, M., Adamo, M., et al. (2021).** 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. *European Heart Journal*, 42(36), 3599–3726.
9. **Rosendaal, F. R., Cannegieter, S. C., van der Meer, F. J., & Briët, E. (1993).** A method to determine the optimal intensity of oral anticoagulant therapy. *Thrombosis and Haemostasis*, 69(3), 236–239.
10. **KDIGO. (2024).** Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. *Kidney International*, 105(4S), S117–S314.

10. Sorumluluk Reddi

Bu rapor, hastanın nesnel klinik verilerinin uluslararası kılavuzlarla sentezlenmesi sonucu oluşturulmuş bir **klinik karar destek aracıdır**. Tıbbi tanı, reçete veya tedavi kararı niteliği taşımaz. Nihai kararlar tedavi eden hekim heyetine aittir. Rapor kodu: CLN-360-KDD-20260909.